Клинические рекомендации

Острый ларингит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J04.0** — Острый ларингит **J04.2** — Острый ларинготрахеит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 01.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/309_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Физикальное обследование 5

3.2 Стадии стеноза гортани 5

3.3 Ларингоскопия 5

3.4 Лабораторные исследования 6

3.5 Инструментальные исследования 6

4. Лечение 6

4.1 Немедикаментозное лечение 6

4.2 Симптоматическая терапия 7

4.3 Местное лечение 7

4.4 Антибактериальная терапия 7

4.5 Антибактериальная терапия у взрослых 8

4.6 Антибактериальная терапия у детей 8

4.7 Лечение в условиях стационара 9

4.8 Дополнительная терапия 10

4.9 Хирургическое лечение 10

4.10 Иное лечение 10

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11

5.1 Показания к госпитализации 11

6. Источник и актуальность 11

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Ларингоскопия показана всем пациентам. С 12 лет выполняется осмотр гортани гортанным зеркалом; если у ребёнка младшего возраста такой осмотр невозможен, проводится видеофиброринофаринголарингоскопия.
- При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов менее 10 дней антибактериальная терапия не назначается.
- При дисфонии показан полный голосовой покой на 1–2 суток с последующим ограничением голосовой нагрузки; из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, необходим отказ от алкоголя и курения.
- Флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит и хондроперихондрит гортани являются показанием к срочной госпитализации в стационар, располагающий отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи.
- Ларингит без стеноза гортани на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не требует госпитализации; экстренная госпитализация показана при дыхательной недостаточности выше I степени.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острый ларингит (ОЛ) представляет собой острое воспаление слизистой оболочки гортани длительностью до 3 недель. При длительности заболевания более 3 недель необходимо исключить его аутоиммунную природу.

Абсцедирующий, или флегмонозный, ларингит является формой острого ларингита с образованием абсцесса, чаще на язычной поверхности надгортанника или на черпалонадгортанных складках. Заболевание проявляется резкой болью при глотании и разговоре с иррадиацией в ухо, повышением температуры тела, плотным инфильтратом в тканях гортани. Острый хондроперихондрит гортани характеризуется острым воспалением хрящей гортани с вовлечением в процесс надхрящницы и окружающих тканей.

Острый подскладочный ларингит (круп) характеризуется воспалением в подголосовом пространстве с отёком слизистой оболочки под голосовыми складками, затруднением дыхания и одышкой. Заболевание встречается у детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.

2.2 Этиология

Как правило, острый ларингит является проявлением острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ): гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, при которых воспалительный процесс затрагивает также слизистую оболочку полости носа и глотки, а в ряде случаев бронхи и лёгкие. Воспаление гортани может быть также продолжением катарального воспаления полости носа или глотки.

Основными возбудителями бактериального ларингита являются S. pneumoniae (20–43%) и H. influenzae (22–35%); достаточно часто высеваются Moraxella catarrhalis (2–10%), различные стрептококки и стафилококки, значительно реже Neisseria, Corynebacterium и другие микроорганизмы.

Помимо инфекции, причинами ларингита являются наружная и внутренняя травма шеи и гортани, в том числе ингаляционная, инородное тело, аллергия, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, повышенная голосовая нагрузка. К предрасполагающим факторам относятся хронические заболевания бронхов и лёгких, полости носа и околоносовых пазух, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания желудочно-кишечного тракта, хроническая почечная недостаточность, нарушение разделительной функции гортани, употребление алкоголя, курение, лучевая терапия в анамнезе.

2.3 Классификация

По форме различают катаральный, отёчный, флегмонозный (инфильтративно-гнойный, в том числе инфильтративный и абсцедирующий) и острый подскладочный ларингит. По этиологии выделяют вирусный, бактериальный, грибковый и специфический ларингит.

2.4 Клиническая картина

Основными симптомами являются нарушение голоса (от лёгкой дисфонии до афонии), острая боль в горле, кашель; возможны затруднение дыхания и ухудшение самочувствия. Заболевание начинается внезапно, на фоне удовлетворительного состояния или небольшого недомогания. При катаральном ларингите температура тела нормальная или субфебрильная; фебрильная лихорадка, как правило, свидетельствует о вовлечении нижних дыхательных путей или о переходе катарального процесса во флегмонозный.

Для инфильтративной и абсцедирующей форм характерны выраженная боль в горле, нарушение глотания, в том числе жидкости, повышенное слюноотделение, вынужденное положение головы, выраженная интоксикация, нарастающие признаки стеноза гортани. Выраженность симптомов соответствует тяжести воспаления; общее состояние становится тяжёлым. При отсутствии адекватного лечения возможно развитие флегмоны шеи, медиастинита, сепсиса, абсцедирующей пневмонии, стеноза гортани.

Клиническая картина острого стеноза гортани не зависит от его причины и определяется степенью сужения: дыхание становится шумным, нарушается его ритм, на вдохе отмечаются западение надключичных ямок и втяжение межрёберных промежутков, пациент запрокидывает голову, гортань опускается на вдохе и поднимается на выдохе.

При неполной обструкции возникает стридор. При преобладании отёка дыхание свистящее, при преобладании гиперсекреции хриплое, клокочущее. В терминальной стадии стеноза дыхание становится всё более тихим вследствие уменьшения дыхательного объёма.

При абсцессе надгортанника на фоне острой боли вначале развивается невозможность глотания, а по мере прогрессирования процесса затруднение дыхания. Голосовая щель может закрыться очень быстро, что требует экстренных мероприятий для спасения жизни пациента.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании анамнеза, жалоб, данных физикального обследования и ларингоскопии. Как правило, заболевание начинается внезапно на фоне небольшого недомогания; пациенты предъявляют жалобы на изменение голоса, боль при глотании, кашель, повышение температуры тела. При тяжёлых формах отмечаются ухудшение общего состояния, боль при глотании даже жидкости, фебрильная лихорадка, повышенное слюноотделение, нарушение дыхания; шея и гортань болезненны при пальпации, подвижность хрящей гортани нарушена, голова и шея в вынужденном положении.

3.1 Физикальное обследование

Пациентам с подозрением на острый ларингит показан осмотр оториноларингологом, врачом общей практики (семейным врачом) или педиатром для постановки и уточнения диагноза.

При осмотре необходимо оценить признаки дыхательной недостаточности, основным из которых является одышка. При I степени одышка возникает при физической нагрузке, при II степени при незначительной нагрузке (неспешная ходьба, умывание, одевание), при III степени в покое.

3.2 Стадии стеноза гортани

Стадия	Признаки
Компенсация	Одышка в покое отсутствует, возникает при ходьбе; просвет гортани сужен на треть.
Субкомпенсация	Инспираторная одышка при нагрузке с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение межрёберных промежутков, яремной и надключичных ямок, стридор, бледность кожных покровов; артериальное давление нормальное или повышенное; просвет гортани сужен наполовину и более.
Декомпенсация	Дыхание поверхностное, частое, резко выраженный стридор, вынужденное положение сидя, максимальные экскурсии гортани, лицо бледно-синюшное, потливость, акроцианоз, пульс частый, нитевидный, артериальное давление снижено; просвет гортани щелевидный.
Асфиксия	Дыхание прерывистое или отсутствует, голосовая щель резко сужена, сердечная деятельность угнетена, пульс частый, нитевидный, часто не определяется, кожные покровы бледно-серые; потеря сознания, экзофтальм, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, остановка сердца.

При быстром нарастании стеноза состояние пациента тяжелее, поскольку компенсаторные механизмы не успевают развиться. Это учитывается при решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве.

3.3 Ларингоскопия

Всем пациентам с острым ларингитом показана ларингоскопия для осмотра гортани.

Непрямая ларингоскопия гортанным зеркалом обязательна при осмотре оториноларингологом пациентов 12 лет и старше как в поликлинике, так и в стационаре. У детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях поликлиники её выполнение часто невозможно из-за эмоциональной лабильности и выраженного глоточного рефлекса; в таких случаях проводится видеофиброринофаринголарингоскопия.

При ларингоскопии определяются характер процесса, его локализация, уровень, протяжённость и степень сужения дыхательных путей. Для острого ларингита характерны гиперемия и отёк слизистой оболочки гортани с усилением сосудистого рисунка; голосовые складки розовые или ярко-красные, утолщены, голосовая щель при фонации овальной или линейной формы, со скоплением мокроты. Процесс может распространяться на подскладковый отдел; при подскладковом ларингите определяется валикообразное утолщение слизистой оболочки под голосовыми складками.

При катаральной форме изменения определяются преимущественно на голосовых складках, в межчерпаловидном или подскладковом пространстве: расширенные поверхностные сосуды, слизистый или слизисто-гнойный секрет, усиливающий охриплость. При отёчной форме вся слизистая оболочка гортани гиперемирована и отёчна, смыкание голосовых складок неполное. При ларингите на фоне гриппа или ОРВИ встречаются кровоизлияния в слизистую оболочку, от петехий до небольших гематом (геморрагический ларингит).

Белый или беловато-жёлтый фибринозный налёт свидетельствует о переходе в более тяжёлую, фибринозную форму, налёт серого или бурого цвета может являться признаком дифтерии. Если налёт у взрослого не связан с интубационной травмой, необходима срочная дифференциальная диагностика с системными заболеваниями и туберкулёзом.

При инфильтративном ларингите поражённый отдел гортани значительно инфильтрирован, гиперемирован, увеличен в объёме, малоподвижен, часто покрыт фибринозными налётами, в зоне формирования абсцесса просвечивает гной. При тяжёлой форме и хондроперихондрите гортань болезненна при пальпации, хрящи малоподвижны, кожа над гортанью может быть инфильтрирована и гиперемирована на фоне болевого синдрома и общей гнойной инфекции. Абсцесс надгортанника определяется как шаровидное образование на его язычной поверхности с просвечивающим гноем и сопровождается выраженной болью и нарушением глотания.

3.4 Лабораторные исследования

Пациентам с острым ларингитом показан развёрнутый общий анализ крови для оценки общего состояния и выявления воспалительной реакции: лейкоцитоза и повышения скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

При флегмонозном ларингите всем пациентам при госпитализации проводится комплексное клинико-лабораторное обследование.

Гнойное отделяемое направляется на посев на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы с идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к антибиотикам и другим препаратам для выбора адекватной терапии.

При поступлении в стационар проводится стандартное лабораторное обследование.

3.5 Инструментальные исследования

Детям младшего и дошкольного возраста проводится пульсоксиметрия для оценки степени дыхательной недостаточности и определения показаний к кислородотерапии.

По показаниям и для дифференциальной диагностики проводится компьютерная томография (КТ) гортани с внутривенным болюсным контрастированием.

КТ целесообразна в условиях стационара при подозрении на гнойные осложнения или при затруднении дифференциальной диагностики с другими заболеваниями гортани. Если у ребёнка с признаками стеноза выполнение КТ невозможно, в сомнительных случаях проводится рентгенография шеи в прямой и боковой проекциях.

---

4. Лечение

Тактика лечения определяется формой и тяжестью воспалительного процесса.

4.1 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам с острым ларингитом при дисфонии любой степени показаны ограничение голосовой нагрузки (исключение крика и шёпота не менее 2 дней) и лечебно-охранительный режим.

При дисфонии рекомендуется полный голосовой покой на 1–2 суток с последующим ограничением любой голосовой нагрузки. Из рациона исключаются острая, солёная, горячая и холодная пища, спиртные напитки; необходим отказ от курения.

> Сроки голосового покоя в тексте рекомендации расходятся: в самой рекомендации указано исключение крика и шёпота «не менее 2-х дней», в комментарии к ней полный голосовой покой «на 1–2 суток».

При катаральном ларингите на фоне ОРВИ повышенное потребление жидкости не рекомендуется.

Польза обильного питья сомнительна, тогда как повышенная в период заболевания секреция антидиуретического гормона способствует задержке жидкости.

4.2 Симптоматическая терапия

Взрослым и детям с фебрильной лихорадкой назначаются противовоспалительные и жаропонижающие препараты.

Детям с температурой тела выше 39–39,5 °C, помимо лекарственных средств, показаны физические методы охлаждения: раскрытие ребёнка и обтирание водой температуры 25–30 °C.

Препарат	Доза
Парацетамол	До 60 мг/кг в сутки. Детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не более 60 мг/кг в сутки.
Ибупрофен	До 30 мг/кг в сутки. Детям — 7,5 мг/кг каждые 6–8 часов, не более 30 мг/кг в сутки.

Детям с острым ларингитом и ларинготрахеитом рутинное назначение противокашлевых и отхаркивающих препаратов не рекомендуется, за исключением случаев мучительного кашля.

Перед назначением противокашлевых средств необходимо исключить состояния, при которых подавление кашля опасно и которые требуют специфического лечения, например бронхиальную обструкцию, а у детей также острый обструктивный ларингит (круп).

4.3 Местное лечение

Для уменьшения воспаления слизистой оболочки гортани назначается местная противовоспалительная терапия: вливания лекарственных препаратов в гортань и ингаляции.

Для вливаний в гортань чаще всего используются антисептики из группы производных хинолина и четвертичных аммониевых соединений. Раствор подогревается до температуры тела и вливается по каплям, в объёме до 2 мл. Детям вливания в гортань не проводятся в связи с угрозой ларингоспазма.

Применяются небулайзерные ингаляции аэрозолей средней и низкой дисперсности.

Продолжительность ингаляции, как правило, составляет 10 минут, интервал между ингаляциями различных препаратов около 30 минут. При наличии корок в гортани ингаляции начинаются с муколитика.

Препарат	Доза
Ацетилцистеин (раствор для инъекций и ингаляций)	Ингаляционно по 1 ампуле (3 мл) 1–2 раза в сутки, 5–7 дней.
#Будесонид	Ингаляционно 1000 мкг 1–2 раза в сутки, курс 5–8 процедур.

Возможно применение готовых аптечных смесей на основе растительных препаратов с учётом противопоказаний и возраста: масла листьев эвкалипта прутовидного, а также 5–10% отваров цветков ромашки, листьев шалфея, травы тимьяна ползучего (чабреца), цветков календулы, листьев подорожника. Такие ингаляции могут быть тёплыми и холодными; продолжительность первой ингаляции составляет 1–2 минуты, последующих 5–10 минут.

4.4 Антибактериальная терапия

При неосложнённом ларингите на фоне вирусной инфекции и длительности симптомов менее 10 дней антибактериальная терапия не назначается.

Системная антибактериальная терапия назначается при сохранении симптомов в течение 10 дней при неосложнённом течении, а также при осложнённом течении заболевания.

Взрослым назначение антибиотика целесообразно при затяжном течении ларингита (10 дней и более), а также при выраженной инфильтрации голосовых складок и экссудации.

Взрослым антибиотик подбирается эмпирически и назначается внутрь: амоксициллин 500–1000 мг 3 раза в сутки 5–10 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой 875/125 мг 2 раза в сутки 5–10 дней; цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5–10 дней; цефдиторен 400 мг 1 раз в сутки 10 дней; кларитромицин 250–500 мг 2 раза в сутки 6 дней; джозамицин 1000 мг 2 раза в сутки 5–10 дней.

4.5 Антибактериальная терапия у взрослых

Препарат	Когда	Доза внутрь
Амоксициллин	Препарат выбора	500 мг 3 раза в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 1000 мг 3 раза в сутки.
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернативный препарат; при факторах риска продукции бета-лактамаз	500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.
Цефиксим	Альтернатива	400 мг 1 раз в сутки.
Цефдиторен	Альтернатива	400 мг; в таблице кратность зачёркнута, в тексте указано 1 раз в сутки.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	250–500 мг 2 раза в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	1000 мг 2 раза в сутки.

Факторами риска устойчивости пневмококка к бета-лактамам являются приём антибиотиков в предшествующие 3 месяца, наличие в семье детей дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, проживание в «закрытых» учреждениях. Амоксициллин с клавулановой кислотой назначается при риске инфицирования возбудителем, продуцирующим бета-лактамазы (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis): при бронхиальной астме, сахарном диабете, хроническом бронхите, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет, при неэффективности предшествующего лечения амоксициллином.

> В тексте рекомендации цефдиторен назначается по 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней, тогда как в таблице 1 кратность его приёма зачёркнута целиком («2 раза в сутки 1 раз в сутки»). Для джозамицина в тексте указан код АТХ J01FA09, совпадающий с кодом кларитромицина, в таблице указан J01FA07.

4.6 Антибактериальная терапия у детей

В тексте рекомендации детям предлагаются: амоксициллин 40–60 или 80–90 мг/кг в сутки 5–7 дней; амоксициллин с клавулановой кислотой до 3 месяцев — 30 мг/кг в сутки в 2 приёма, с 3 месяцев — 25 мг/кг в сутки в 2 приёма или 20 мг/кг в сутки в 3 приёма, 5–10 дней; цефиксим в суспензии 8 мг/кг в сутки в 1–2 приёма 5–10 дней; цефтриаксон с 15 дней до 12 лет 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых; кларитромицин 7,5–15 мг/кг в сутки в 2 приёма не более 14 дней; джозамицин 50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма 5–10 дней; тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат внутримышечно 10 дней.

Препарат	Когда	Доза
Амоксициллин	Препарат выбора	Внутрь 40–60 мг/кг в сутки; при факторах риска устойчивости пневмококка — 80–90 мг/кг в сутки.

Препарат	Когда	Доза
Амоксициллин + клавулановая кислота	Альтернатива	Внутрь, суспензия 4:1 (125 мг + 31,25 мг в 5 мл или 250 мг + 62 мг в 5 мл) в 3 приёма каждые 8 часов; доза «45–60 мг/кг/сутки в 2–3 приёма» в таблице зачёркнута.
Цефиксим	Альтернатива	8 мг/кг в сутки 1 раз в сутки.
Цефтриаксон	Альтернатива	С 15 дней до 12 лет — 20–80 мг/кг 1 раз в сутки; при массе тела более 50 кг — дозы для взрослых.
Кларитромицин	Аллергия на бета-лактамы	Внутрь 7,5 мг/кг в сутки в 2 приёма, не более 1000 мг в сутки.
Джозамицин	Аллергия на бета-лактамы	50 мг/кг в сутки в 2–3 приёма.
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	При невозможности применения бета-лактамов и макролидов	До 2 лет — по 125 мг 2 раза в сутки; 3–6 лет — по 250 мг 2 раза в сутки; 7–12 лет — по 250 мг 3 раза в сутки; взрослым — по 500 мг 2–3 раза в сутки; 10 дней.

> Детские дозы в тексте и в таблице 2 не совпадают. Для кларитромицина в тексте указана «для детей старше 12 лет разовая доза» 7,5–15 мг/кг/сут, в таблице 7,5 мг/кг/сут в 2 приёма. Для амоксициллина с клавулановой кислотой в тексте приведена доза 20–30 мг/кг/сут, в таблице доза 45–60 мг/кг/сут зачёркнута и указана только суспензия в 3 приёма. Цефиксим в тексте назначается в 1–2 приёма, в таблице 1 раз в сутки. Для тиамфеникола возрастные группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет» не включают детей от 2 до 3 лет.

4.7 Лечение в условиях стационара

В стационаре антибактериальная терапия взрослым и детям назначается эмпирически с учётом региональной резистентности основных возбудителей. После улучшения состояния возможен переход на пероральный приём антибиотика (ступенчатая терапия).

Препарат	Детям	Взрослым (осложнённый флегмонозный ларингит)
Амоксициллин + клавулановая кислота	С 3 месяцев внутривенно 25/5 мг/кг каждые 6–8 часов, 5–10 дней	Внутривенно 1,2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефотаксим	Внутримышечно или внутривенно 150 мг/кг в сутки в 4 введения	Внутривенно 2 г 3 раза в сутки, 7–10 дней
Цефтриаксон	С 15 дней до 12 лет внутримышечно или внутривенно 20–80 мг/кг 1 раз в сутки, 5–10 дней	Внутримышечно или внутривенно 2 г 1 раз в сутки, 7–10 дней
Цефепим	При тяжёлом флегмонозном ларингите и осложнениях в отделении реанимации: при массе тела более 40 кг — 2 г каждые 12 часов, до 40 кг — 50 мг/кг каждые 12 часов, 7–10 дней	—
Меропенем	В тех же условиях: от 3 месяцев до 12 лет — 10–20 мг/кг 3 раза в сутки, при массе тела более 50 кг — доза для взрослых, 5–10 дней	—
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат	До 2 лет — 125 мг 2 раза в сутки, 3–6 лет — 250 мг 2 раза, 7–12 лет — 250 мг 3 раза в сутки	500 мг 2–3 раза в сутки, 10 дней

При абсцедирующем и флегмонозном ларингите всем пациентам проводится промывание полости абсцесса растворами антисептиков: 0,01% раствором бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммония хлорида моногидрата или гидроксиметилхиноксалиндиоксидом.

Всем пациентам с дисфагией при тяжёлых формах ларингита проводятся дезинтоксикационная терапия и коррекция гиповолемии, назначаются глюкокортикостероиды и парентеральное питание.

Для профилактики стеноза гортани проводится консервативная противовоспалительная терапия; в качестве дестенозирующей терапии применяется парентеральное введение глюкокортикоидов.

> В комментарии о дестенозирующей терапии фраза оборвана: указана доза «60–120 мг», однако не указано, к какому глюкокортикоиду она относится и предназначена ли она для взрослых или для детей.

4.8 Дополнительная терапия

Эмпирическое назначение противогрибковых препаратов не рекомендуется. Только после подтверждения кандидоза взрослым назначается флуконазол 100 мг в сутки или итраконазол 100 мг 1 раз в сутки в течение 15 дней.

Пациентам с аллергическими заболеваниями (аллергический ринит, крапивница, поллиноз, аллергический конъюнктивит) назначаются системные антигистаминные препараты.

Препарат	Доза
Лоратадин, цетиризин	Детям 3–12 лет с массой тела более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки, менее 30 кг — 5 мг 1 раз в сутки; взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки; старше 6 лет и взрослым — 5 мг 1 раз в сутки.
Дезлоратадин	От 6 до 12 месяцев — 1 мг, с 1 года до 5 лет — 1,25 мг, 6–11 лет — 2,5 мг, взрослым и детям старше 12 лет — 5 мг; кратность приёма 1 раз в сутки.

> Левоцетиризину и лоратадину в тексте рекомендации присвоен один и тот же код АТХ R06AX13.

4.9 Хирургическое лечение

При неосложнённом остром ларингите хирургическое лечение не требуется.

Детям с декомпенсированным стенозом гортани для обеспечения дыхания проводится неотложная интубация трахеи.

При невозможности интубации трахеи выполняется трахеостомия или коникотомия.

При осложнённых формах острого ларингита показано хирургическое лечение.

4.10 Иное лечение

Пациентам с острым ларингитом показана консультация физиотерапевта.

При дисфонии на фоне острого ларингита рекомендацией предусмотрено включение в терапию комплексных гомеопатических препаратов для уменьшения выраженности нарушений голоса. Приведённый в рекомендации препарат зарегистрирован по показанию «ларингиты различной этиологии» и назначается взрослым и детям старше 6 лет с первых дней заболевания на 6 дней.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Пациентам голосоречевых профессий после перенесённого острого ларингита показано наблюдение оториноларинголога до полного восстановления голосовой функции.

Сроки нетрудоспособности у таких пациентов продлеваются до полного восстановления голоса. Неосложнённый ларингит разрешается за 7–14 дней, разрешение инфильтративных форм занимает более 14 дней.

Профилактика хронизации воспалительного процесса гортани заключается в своевременном лечении острого ларингита, повышении сопротивляемости организма, лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и инфекций верхних и нижних дыхательных путей, отказе от курения и соблюдении голосового режима.

Пациенту рекомендуется ограничить голосовую нагрузку, исключить горячую, холодную и острую пищу, спиртные напитки, курение и паровые ингаляции, постоянно увлажнять воздух в помещении с помощью увлажнителя; в составе комплексного лечения в рекомендации упоминаются противовирусные препараты.

> В разделе 7 и в памятке для пациента паровые ингаляции запрещены, тогда как в разделе 3.1 ингаляции отваров трав допускаются «тёплыми». Там же рекомендованы противовирусные препараты, однако в разделе о лечении такая рекомендация отсутствует.

5.1 Показания к госпитализации

Пациенты с острым ларингитом без стеноза гортани на фоне ОРВИ не нуждаются в госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты с осложнённым течением.

Пациенты с осложнёнными и тяжёлыми формами (флегмонозный, абсцедирующий, инфильтративный ларингит, хондроперихондрит гортани) подлежат обязательной срочной госпитализации в учреждение, располагающее отделением интенсивной терапии и возможностью интубации трахеи.

Показанием к экстренной госпитализации является острая дыхательная недостаточность выше I степени.

Пациент выписывается при регрессе воспалительных изменений, отсутствии дыхательной недостаточности и осложнений.

При неосложнённом ларингите прогноз благоприятный. При осложнённых формах со стенозом гортани решающее значение для сохранения жизни пациента имеют своевременная специализированная помощь и хирургическое лечение.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый ларингит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 01.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее ноября 2027 года
Код в рубрикаторе	`309_2` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Союз педиатров России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки голосового покоя расходятся: в рекомендации указано «не менее 2-х дней», в комментарии к ней «1–2 суток».
- Для цефдиторена в тексте указано 400 мг 1 раз в сутки, в таблице 1 кратность зачёркнута целиком.
- Джозамицину в тексте присвоен код АТХ J01FA09 (код кларитромицина), в таблице указан J01FA07.
- Детские дозы кларитромицина, амоксициллина с клавулановой кислотой и цефиксима в тексте и в таблице 2 различаются; для кларитромицина «разовая доза» приведена в мг/кг/сут и «для детей старше 12 лет».
- Для тиамфеникола глицината ацетилцистеината не указана доза для детей от 2 до 3 лет: выделены только группы «до 2 лет» и «от 3 до 6 лет».
- В комментарии о дестенозирующей терапии не назван глюкокортикоид, к которому относится доза «60–120 мг».
- Левоцетиризину и лоратадину присвоен один и тот же код АТХ R06AX13.
- Раздел 7 запрещает паровые ингаляции и рекомендует противовирусные препараты, тогда как раздел 3.1 допускает тёплые ингаляции и не содержит рекомендации о противовирусных препаратах.
- В комментарии о меропенеме для детей авторы ссылаются на справочник Vidal.